FESTINA LENTE
CONSULTING

Documento para el panel de expertos

Matriz de cambios: revisión 2 del manuscrito

Cliente:	Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y metabolismo (ACE)
Asunto:	Declaración de posición sobre hipoparatiroidismo crónico en Colombia
Dirigida a:	Panel de expertos
Fecha de entrega:	10/11/2026
Contacto para inquietudes:	Carlos E. Builes Montaño | cbuiles@festinalente.cc|3053385136

Gracias por la segunda revisión. Recibimos 17 comentarios y 6 textos resaltados en el documento del 8 de noviembre de 2026. Todos los comentarios se aceptaron; algunos con ajustes de redacción que se explican abajo. La tabla resume cada comentario agrupado por tema, la respuesta y el cambio hecho en el manuscrito, que se adjunta. Al final se incluyen los ajustes que hizo el equipo coordinador en esta versión.

1. Terminología de la definición

Dónde	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
Resumen; paso 6	Especificar «dominios de control inadecuado».	Aceptado: «two or more domains of inadequate control» y «one domain of inadequate control».
Condición 3	Añadir la referencia a la Tabla 1 en «un dominio».	Aceptado: «one domain (Table 1)».
Resumen; definiciones; condición 3; paso 5; Tabla 2	La intolerancia debe referirse a altas dosis de calcio y calcitriol.	Aceptado: «persistent intolerance to high doses of calcium and calcitriol». En la Tabla 2: efectos adversos no metabólicos, sobre todo gastrointestinales, atribuibles a las dosis altas necesarias para el control. La dosis alta por sí sola sigue siendo un punto de buena práctica (Recuadro 2), no una indicación.

2. Optimización (paso 2 y Recuadro 1)

Dónde	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
Paso 2	Cambiar «hipercalcemia» por «calcio por encima de las metas».	Aceptado: «calcium above target, including hypercalcemia».
Recuadro 1, fósforo	Hacer énfasis en el fósforo inorgánico.	Aceptado: «dietary phosphate moderated, especially inorganic phosphate from food additives».
Recuadro 1, tiazida	Dar un ejemplo de dosis: hidroclorotiazida 25 mg cada 12 horas.	Aceptado. Coincide con la guía ESE 2025, que sugiere tiazida en dosis relativamente alta dos veces al día.
Recuadro 1, tiazida	Añadir hiponatremia, hipopotasemia, hipomagnesemia e hipotensión.	Aceptado como vigilancia de efectos adversos de la tiazida.

Dónde	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
Recuadro 1, dosis por toma	Explicar que la absorción de calcio es saturable.	Aceptado: «500 mg or less of elemental calcium per intake, because intestinal calcium absorption is saturable».
Recuadro 1, nuevo ítem	Supresión excesiva de la TSH con levotiroxina: ajustar la dosis según la meta de cada paciente.	Aceptado en el ítem de fármacos y condiciones que interfieren: «including excessive TSH suppression with levothyroxine, whose dose should be adjusted to each patient's target». El mecanismo propuesto (tránsito intestinal, absorción de calcio) no se incluyó porque no encontramos una referencia que lo respalde; puede añadirse si se aporta una.

3. Dosis alta (Recuadro 2)

Dónde	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
Recuadro 2	Aunque no hay dosis mínima de calcitriol, no es apropiado mantener calcio sin calcitriol.	Aceptado: «although calcium supplementation without active vitamin D is not appropriate in chronic hypoparathyroidism».

4. Definiciones operativas (Tabla 1)

Dónde	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
Tabla 1, urgencias	Precisar el desencadenante identificable o corregible.	Aceptado: «An episode with an identifiable or correctable trigger does not count; triggers include intercurrent illness and interruptions in drug dispensing».

5. Textos resaltados

Dónde	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
Resumen; conclusiones; primer párrafo de la declaración	Resaltados en amarillo: «candidate for evaluation of PTH replacement», «clinical candidacy» y la frase que separa mal control de limitaciones.	Se mantienen. Proponemos, si el panel lo considera útil, un recuadro de mensajes clave al inicio que destaque estas ideas.
Párrafo sobre las listas no votadas	Resaltado en amarillo: las listas de verificación, notas de la Tabla 1 y definiciones de la Tabla 2 no se votaron y se aprueban en esta revisión.	Se mantiene. Su aprobación por el panel en esta ronda cierra este punto; agradecemos indicar cualquier desacuerdo.

6. Ajustes del equipo coordinador

Dónde	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
Resumen; Métodos, Panel	Describir mejor la composición del panel.	Se especifica que una de las endocrinólogas es pediatra (perspectiva del hipoparatiroidismo de inicio en la infancia y la transición a la atención de adultos) y que la internista fue invitada por su experiencia de seis años en la toma de decisiones de una aseguradora, no por su

Dónde	Comentario	Respuesta y cambio en el manuscrito
		especialidad.
Métodos; Limitaciones	Ordenar la sección de cambios al proceso y las limitaciones.	La sección se titula ahora «Changes to the planned process». El anonimato parcial durante la deliberación se describe en Limitaciones. Limitaciones señala que la perspectiva del asegurador no formó parte de la deliberación presencial.
Discusión, «Inadequate control and limitations of therapy»	Ruta hacia el reemplazo con PTH desde las complicaciones del tratamiento convencional (por ejemplo, nefrocalcinosis), y no desde la falta de control.	Se añade un párrafo. Las guías internacionales describen dos rutas: falta de control y complicaciones del tratamiento. En esta declaración, la nefrolitiasis o nefrocalcinosis y el deterioro progresivo de la función renal son dominios (Tabla 1) y siguen la misma regla que los demás. Una complicación renal rara vez ocurre sola: suele acompañarse de hipercalciuria o de un producto calcio × fósforo alto, que cuentan como dominios separados. El panel no valoró el caso de una complicación renal aislada con los demás parámetros en meta. Por la regla general no bastaría por sí sola (A1 y D3), pero requiere juicio individual y debe abordarse en futuras actualizaciones.
Afiliaciones	Afiliación de una panelista que cambió durante el proyecto.	Se usa la afiliación al momento del estudio y se añade la dirección actual, según las recomendaciones ICMJE.

Puntos abiertos

- ¿Incluimos un recuadro de mensajes clave al inicio con la definición de candidato y la separación entre mal control y limitaciones?
- Si alguien cuenta con una referencia para el efecto de la supresión de la TSH sobre la absorción de calcio, puede añadirse el mecanismo al Recuadro 1.

Con la aprobación del panel, el documento se compartirá con los miembros de la ACE para comentarios cualitativos.

CONFIDENCIALIDAD

La presente información se entrega con el entendimiento de que será manejada bajo estricta confidencialidad. La información no deberá ser revelada, duplicada o usada en su totalidad ni parcialmente, para ningún otro propósito que no sea la evaluación de este material al interior de Festina Lente y la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. De ninguna manera los asuntos descritos en este documento pueden ser revelados a otras personas, excepto aquellas que sean aprobadas de forma

explícita por Festina Lente.

¡Gracias por confiar en nosotros!